

長聖

(6712 TT, NT\$151, 未評等)

重點摘要

1. 長聖採 CDMO 與新藥研發雙軌模式，CDMO 提供穩定現金流以支撐新藥開發。核心產品 CAR-001 為異體實體瘤 CAR-T，以 $\gamma\delta$ T 細胞為載體、採 HLA-G 與 PD-L1 $\times$ CD3 雙靶點設計；Phase 1 已於 2Q26 完成，15 例中免疫細胞神經毒性症候群與移植抗宿主疾病皆為 0，1 例復發型膠質母細胞瘤達完全緩解並維持至 Day 382。
2. 短期聚焦 Phase 2a 與法規加速。Phase 2a 於 7M26 展開、預計收案 27 例，涵蓋大腸直腸癌、膠質母細胞瘤、三陰性乳癌與非小細胞肺癌，首例已於 2026/6/30 收治，目標 2027 年完成。依再生醫療製劑管理條例，二期完成後可申請五年附款許可，2028 年有機會取得台灣臨時藥證并啟動多國多中心 Phase 2b。
3. 長期成長來自外泌體平臺與國際授權。EXO-001 以外泌體遞送 CAR mRNA、於體內生成 CAR-T；dEV-001 靶向多巴胺神經元、切入帕金森氏症，兩者新藥臨床試驗申請均以 2027 年為目標。UMSC01 三項適應症分別進入 Phase 1 至 Phase 2a，CAR-001 亦已與多家國際藥廠簽署保密協議。

結論

長聖以 CDMO 現金流支撐新藥開發，屬國內少數具自有營收的研發型生技。CAR-001 的完全緩解屬單一個案，療效仍待 Phase 2a 放大驗證；惟異體現成型與靜脈給藥為相對國際同業的明確差異化，四項適應症 2030 年市場規模合計逾 700 億美元，隨 Phase 2a 數據累積與 2028 年臨時藥證時程推進，公司在實體瘤 CAR-T 的先行者位置可望持續強化。

雙軌營運模式與再生醫療雙法紅利

- CDMO 生態系涵蓋細胞來源、製程開發、GMP 生產、品質管理、臨床執行與法規申請六個環節，為新藥研發的資金來源；特管辦法于 2025 年底結束，DC、CIK、DC-CIK、GDT 等原核准項目全數延續至再生醫療技術
- 2025 年底雙法公布期間市場一度觀望、收案量稍降，目前已回升并在成長中
- 再生醫療製劑管理條例第 9 條提供五年期附款許可，危及生命或嚴重失能疾病之療法完成二期臨床即可申請，可于三期期間先行商業化，縮短開發與營收的時間差、降低三期資金壓力
- 恩慈療法路徑可讓尚未符合收案條件的病人先行使用、提早帶進現金流，適用品項為 CAR-001（癌症）與 UMSC01（急性心肌梗塞、急性腦中風、多發性硬化症）

凱基投顧

陳宣甫
886.2.2181.8724
hsuan.chen@kgi.com

徐雋翔
886.2.2181.8745
kenny.ch.hsu@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

CAR-001 為全球首款異體實體瘤 CAR-T

- 現行 CAR-T 療法存在兩大限制
 - 自體療法每位患者皆為獨立生產批次，製程約需 30 天，全球費用約 30-45 萬美元、台灣健保核價 26 萬美元
 - 應用高度集中于血液腫瘤（約占所有癌症 10%），實體瘤約占 90%，截至 2026/6 全球尚無實體瘤 CAR-T 上市藥物
- CAR-001 改採健康成年人捐贈的異體細胞，可預先批次生產、凍存與品質檢測，隨取隨用；細胞品質優於狀況不佳病患的自體 T 細胞，費用有機會降至現行自體療法的 1/5
- 載體選用 $\gamma\delta$ T 細胞而非傳統 $\alpha\beta$ T 細胞
 - $\alpha\beta$ T 以主要組織相容性複合體（MHC）限制方式辨識抗原，異體輸注時會把宿主組織當成外來抗原攻擊，為移植物抗宿主疾病（GvHD）的主要來源； $\gamma\delta$ T 不受 MHC 限制，且具備辨識腫瘤壓力訊號的先天毒殺能力
 - 人類周邊血單核細胞（PBMC）中 $\alpha\beta$ T 約占 60%、 $\gamma\delta$ T 僅 1-10%；CAR-001 最終產品（DP）中 $\gamma\delta$ T 達 97.10%、 $\alpha\beta$ T 殘留 0.015%
- 雙靶點加雙特異性抗體（BiTE）形成三重毒殺機制：奈米抗體 CAR（Nb-CAR）精準辨識並毒殺 HLA-G 陽性腫瘤、分泌 PD-L1 $\times$ CD3 BiTE 號召患者免疫細胞攻擊 PD-L1 陽性腫瘤，兩種抗原皆陰性時由 $\gamma\delta$ T 細胞受體（TCR）天然毒殺補位；HLA-G 不表現于正常組織，攻擊正常組織（on-target off-tumor）的風險低
- 專利已于美國、歐盟、日本、中國與台灣布局，共 18 件申請、16 件獲准

Phase 1 安全性與膠質母細胞瘤完全緩解個案

- Phase 1 已於 2Q26 完成並求得最大耐受劑量（MTD），5 個劑量組、每組 3 例合計 15 例，輸注自低劑量單劑遞增至高劑量四劑，收治無法切除之局部晚期或轉移性實體瘤且完成至少兩綫標準治療者
 - 組成為大腸直腸癌 10 例、膠質母細胞瘤 3 例、三陰性乳癌 1 例、非小細胞肺癌 1 例
- 57 件不良事件中，判定與 CAR-001 相關者僅 Grade 1 細胞激素釋放症候群（CRS）4 件、Grade 2-3 為 0 件，免疫細胞神經毒性症候群（ICANS）與移植物抗宿主疾病各級別皆為 0
 - 不良事件以腸胃道為主，Grade 1 發燒以普拿疼即可退燒
- 中劑量組出現 1 例復發型膠質母細胞瘤完全緩解
 - Day 49 病灶較基期增加 4.62%、判定疾病穩定（SD），判讀為假性惡化；Day 101 減少 76.90%、判定部分緩解（PR）；Day 196 病灶歸零、判定完全緩解（CR）
 - Day 290、Day 319 與 Day 382（試驗結束）均維持 CR，全程未使用類固醇

- 另兩例膠質母細胞瘤落在劑量偏低的 Cohort 1 與 Cohort 2；Phase 1 主要目的為安全性探討，療效訊號須靠 Phase 2a 放大驗證

與國際復發型膠質母細胞瘤研究之對照

- UPenn 自體 EGFR + IL13R α 2 雙 CAR-T 收 6 例、MGH 自體 CARv3-TEAM-E 收 3 例，均採鞘內或腦室內給藥，前者無人達正式客觀緩解率（ORR），後者快速縮小但均後續復發
- City of Hope 自體記憶型 IL13R α 2-CAR-T 收 65 例，58 例可評估中 29 例 SD 以上、2 例 PR、1 例 protocol 內 CR，復發型膠質母細胞瘤全體中位存活期（mOS）7.7 個月
- Bevacizumab 後進展之歷史資料涵蓋 2,388 例，後續 mOS 3.36 個月，接受後線救援治療者約 4.46 個月
- CAR-001 採靜脈輸注四次給藥，為上述比較中唯一非侵入性途徑，病患不需再承受顱內或鞘內注射

Phase 2a 設計、收案節奏與里程碑

- Phase 2a 預計收案 27 例，涵蓋大腸直腸癌、膠質母細胞瘤、三陰性乳癌與非小細胞肺癌之晚期／難治或治療後復發病患，主要以 ORR 評估初步抗腫瘤能力，並累積疾病控制率（DCR）、反應持續時間（DoR）與整體存活期（OS），統一採 Cohort 5 劑量
 - 目前收案以大腸直腸癌與膠質母細胞瘤為主，與 Phase 1 組成一致
- 7M26 展開試驗，首位受試者已於 2026/6/30 收治，8M26 起每月約可納入 2-3 例，目標 2027 年完成 Phase 2a、期望於 1H27 完成收案
 - Phase 1 每例須觀察一個月才能收下一例，Phase 2a 改為同一劑量連續收案，試驗中心並由 1 個增為 2 個
- 已就膠質母細胞瘤向美國 FDA 申請孤兒藥認證（ODD），並規劃於 Phase 2a 初期評估快速審查資格（Fast Track Designation）
- 2027 年完成 Phase 2a 後，2028 年將啟動多國多中心 Phase 2b，並申請台灣五年臨時藥證
- 四大適應症 2030 年市場規模為非小細胞肺癌 441 億美元、大腸直腸癌 179 億美元、膠質母細胞瘤 66 億美元、三陰性乳癌 61.2 億美元

外泌體平臺：dEV-001 與 EXO-001

- dEV-001 以修飾療法切入帕金森氏症
 - 以基因工程化臍帶間質幹細胞分泌外泌體，透過 CD63 展示 α DAT 奈米抗體，靶向多巴胺神經元表面的多巴胺轉運蛋白（DAT）；所選細胞株腦源性神經滋養因子（BDNF）分泌較高，訴求為疾病修飾潛力而非補充多巴胺

- 研究成果已發表于 Journal of Nanobiotechnology，動物試驗顯示可改善帕金森氏症模型小鼠運動功能并緩解神經發炎
- 動物試驗與美國 FDA 新藥臨床試驗申請前會議（Pre-IND Meeting）已完成、化學製造與管制（CMC）開發進行中，IND 預計 2027 年提出
- EXO-001 布局體內生成型（in vivo）CAR-T
 - 靜脈注射後透過帶 CD3ε 靶向的外泌體將 CAR mRNA 遞送至 T 細胞、於體內生成 CAR-T；CAR 序列與 CAR-001 相似，差別在改用細胞外囊泡（EV）遞送，生產複雜度與費用負擔為三者最低
 - 大腸直腸癌動物模型成果已刊登于 Advanced Science
- 兩案共同瓶頸在於須先建置外泌體細胞庫且部分須與大廠協同；in vivo CAR-T 併購熱度高，2025/03 以來已有六筆交易，最大一筆為 2026/04 Eli Lilly 以 70 億美元收購 Kelonia Therapeutics

UMSC01 與 CDMO 營運

- UMSC01 取自新生兒臍帶，具高增殖、低免疫原性與異體使用潛力，透過免疫調節與分泌血管新生及神經保護因子改善受損微環境
 - 多發性硬化症（NCT05532943）Phase 2a 收案中
 - 急性缺血性腦中風（NCT04434768）Phase 1 收案完成
 - 急性心肌梗塞（NCT06147986）Phase 2a 收案中
 - 其中心肌梗塞進度最快，結束後可申請臨時藥證
 - 三大適應症 2030 年市場規模為多發性硬化症 416 億美元、缺血性腦中風 24 億美元、急性心肌梗塞 7.3 億美元；已成立美國子公司，以技術作價取得合資公司 48.78% 股權並取得 300 萬美元授權金
- CDMO 品項涵蓋多種癌別，需取腫瘤組織者為 DCV01、DCV02 與 DC-CIK 01，不須取腫瘤組織者為 DC-CIK(WT-1)、GDT、DC(WT-1) 與 CIK，另有 BMSC 用於退化性關節炎與脊髓損傷、ADSC 用于困難傷口
- 醫院拓展複製與中國附醫的合作模式，中部、北部、南部與東部皆已有合作對象；品質面已取得美國血庫協會（AABB）認證，四個專案皆通過

QA

- CAR-001 的國際授權洽談進展到什麼程度？
 - 已與多家國際藥廠簽署保密協議，家數未揭露，目前僅止于資料交換與評估，尚未進入正式程序
 - 藥廠關注無惡化存活期（PFS）、OS 與疾病控制等指標，完全緩解屬單一個案，對方希望看到樣本數更大的資料；授權時點取決于資料強度，公司未給時間表

- Phase 2a 收 27 例是否足夠？
 - 27 例對 Phase 2a 而言是可談的規模，若能集中在某一適應症且效果够好，樣本數不見得需要很大
 - Cohort 5 的療效資料仍在整理，結束後尚需一個月追蹤，預計 8M26 底至 9M26 中出爐
- CAR-001 與現有 CDMO 收治的病患是否會互相取代？
 - 兩者有明確區隔，CAR-001 為異體且走藥證路徑，DC-CIK 等屬自體細胞治療，取得藥證後療程時間更短
 - 價格差距明顯，CAR-T 一個療程 800 多萬元、一般細胞治療約 100 多萬元；公司預期會有部分替代，也會擴充新的適應症與病患來源
- 取得臨時藥證後健保是否給付？
 - 藥證不等於健保給付，取得後仍須另外申請
 - 政府設有癌症基金，原本規模 50 億元、目前已再增加 50 億元，不會排擠健保既有費用
- 2H26 與 2027 年 CDMO 營收展望如何？
 - 2025 年底法規銜接期的觀望造成 1H26 前幾個月基期偏低，目前收案量已回升
 - 2H26 至少可維持既有水準，公司未對大幅成長作出承諾；2026 年全年將優於 2025 年，後段月份成長已較前段明顯

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股(OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有(N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股(U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等(NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等(R)	
*總報酬=(十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。